·医学循证·

基于文献计量法分析健康相关生命质量量表在慢性肝炎领域中的应用

冉雪蓉[1]，张堂钦[1]，蔡一凡[1]，罗奎[1]，伍红艳[1*]，杨星[1]，张满[2]

【摘要】 **目的** 分析慢性肝炎领域健康相关生命质量量表的应用现状，为我国研究者开展慢性肝炎患者生命质量评价，尤其是健康相关生命质量量表选择提供参考。**方法** 2017年3—9月，计算机检索中国知网、万方数据知识服务平台、维普网和中国生物医学文献数据库，查找慢性肝炎患者生命质量评价的相关文献，提取文献一般情况、研究内容、生命质量量表应用等内容。**结果** 共检索到233篇文献，其中期刊文献221篇，会议文献12篇。排除无法确定量表开发者的文献，应用国外开发的普适性量表、特异性量表和心理健康测量量表的频次分别为150（75.76%）、42（65.63%）、92（95.83%）次，国内开发的量表应用频次分别为37（18.67%）、10（15.63%）、0次。158篇（67.81%）文献单独选用普适性量表（124篇，78.48%）、特异性量表（17篇，10.76%）、心理健康测量量表（17篇，10.76%）中的一类，其中分别选择健康调查简表（SF-36）、慢性肝病问卷（CLDQ）、焦虑自评量表（SAS）+抑郁自评量表（SDS）的文献较多；71篇（30.47%）文献选择两类量表开展评价，应用较多的量表组合为SF-36/世界卫生组织生存质量测定量表简表（WHOQOL-BREF）+CLDQ、SF-36/WHOQOL-BREF/生活质量综合评定问卷（GQOLI-74）+SAS/SDS、CLDQ+SAS/SDS。仅4篇（1.72%）文献同时选择3类量表进行评价，为WHOQOL-BREF+CLDQ/社会功能缺陷筛选量表（SDSS）/服药依从性量表+SAS/SDS。**结论** 在慢性肝炎领域，目前国内大多数文献仍采用国外开发的量表，基于本国国情的量表尚需进一步的研发及推广，以为研究者在进行慢性肝炎患者生命质量评价时提供更广泛的选择。

【关键词】 肝炎，慢性；生活质量；量表；文献计量法
【中图分类号】 R 575.1 【文献标识码】 A DOI：10.12114/j.issn.1007-9572.2018.00.105
冉雪蓉，张堂钦，蔡一凡，等. 基于文献计量法分析健康相关生命质量量表在慢性肝炎领域中的应用［J］. 中国全科医学，2018，21（35）：4377-4382. ［www.chinagp.net］
RAN X R，ZHANG T Q，CAI Y F，et al. Bibliometric analysis of health-related quality of life assessment instruments for chronic hepatitis patients［J］. Chinese General Practice，2018，21（35）：4377-4382.

Bibliometric Analysis of Health-related Quality of Life Assessment Instruments for Chronic Hepatitis Patients

RAN Xuerong[1]，*ZHANG Tangqin*[1]，*CAI Yifan*[1]，*LUO Kui*[1]，*WU Hongyan*[1*]，*YANG Xing*[1]，*ZHANG Man*[2]
1.School of Medicine and Health Management，Guizhou Medical University，Guiyang 550004，China
2.Guizhou Provincial People's Hospital，Guiyang 550002，China
**Corresponding author：WU Hongyan，Professor，Master supervisor；E-mail：why376570155@126.com*

【**Abstract**】 **Objective** To analyze the application of health-related quality of life（HRQOL）instruments in chronic hepatitis patients，providing a reference for quality of life assessment including the choice of an appropriate instrument in such a population in China.**Methods** From March to September 2017，we searched the databases of CNKI，Wanfang Data Knowledge Service Platform，VIP and CBM，to identify the articles about HRQOL assessment.We analyzed the included articles by general information and contents of article，type of used HRQOL instrument and so on.**Results** A total of 233 articles were included，including 221 journal articles and 12 conference articles.Except those using instruments developed by the undetermined developer，among the remaining articles，the using times of general HRQOL instruments，chronic hepatitis-specific HRQOL instruments，and mental health assessment instruments developed in foreign countries were 150（75.76%），42（65.63%），92（95.83%），respectively，while those of the aforementioned 3 types of instruments developed in China were 37（18.67%），10（15.63%），0，respectively.158 articles（67.81%）used 1 type of HRQOL instrument［including 124（78.48%），17

基金项目：国家自然科学基金资助项目（71463007）；贵州省科技厅社会攻关项目（黔科合SY字［2013］3068）；贵州省教育厅高校人文社会科学研究项目（2017ssd01）
1.550004 贵州省贵阳市，贵州医科大学医药卫生管理学院 2.550002 贵州省贵阳市，贵州省人民医院
*通信作者：伍红艳，教授，硕士研究生导师；E-mail：why376570155@126.com

（10.76%），17（10.76%）using the general HRQOL instrument and chronic hepatitis-specific HRQOL instrument，mental health assessment instrument，respectively〕，most of which used SF-36，CLDQ or SAS+SDS.Seventy-one（30.47%）used 2 types of HRQOL instruments，and most of which used SF-36/WHOQOL-BREF+CLDQ，SF-36/WHOQOL-BREF/GQOLI-74+SAS/SDS，or CLDQ+SAS/SDS.Four（1.72%）used 3 types of HRQOL instruments of WHOQOL-BREF+CLDQ/SDSS/medication adherence scale+SAS/SDS.**Conclusion** For assessing HRQOL of chronic hepatitis patients，most articles published in China use foreign instruments，and domestic instruments need to be further developed and used extensively by which more choice can be offered for such studies.

【**Key words**】 Hepatitis，chronic；Quality of life；Assessment instruments；Bibliometrics

慢性肝炎是由病毒、药物、乙醇、自身免疫等多种原因引起，以肝脏炎性病变及慢性肝脏损害为主的一组肝脏疾病的统称，最终可发展为肝硬化或肝癌[1-2]。据世界卫生组织统计，全世界约有14亿以上人口患有慢性肝炎[3-7]，其中亚洲占2/3，中国占1/3，而我国以慢性乙型肝炎最常见[8-9]。慢性肝炎由于病程长、预后差、易反复，缺乏有效的治疗手段，严重危害人体健康[10]。国家卫生健康委员会疾病预防控制局公布的2016年全国法定传染病疫情概况显示，我国肝炎患病率为89.108/10万，死亡率为0.039 2/10万，分别位列第1、4位[11]。另有研究表明，10%~30%的慢性肝炎最终发展为肝硬化，进入肝硬化阶段后，大部分患者临床症状凸显，代偿性肝硬化患者5年存活率为84%，10年存活率为68%，失代偿性肝硬化患者存活率仅为14%[12-13]。

由于目前的医疗水平不能有效根治慢性肝炎，而该疾病对患者生理、心理及社会适应方面均存在显著影响。在我国，每年用于慢性肝炎或慢性肝病的医疗和保健相关费用高达1 000多亿元[14]。因此，采用健康相关生命质量这一综合指标来评价慢性肝炎的治疗效果并测算其疾病经济负担受到越来越多的重视[15-16]。量表是评价健康相关生命质量最重要的测量工具，其通常由一系列反映患者身体状况、精神状况、社会关系以及其他与疾病或治疗相关的多个维度和条目组成。根据量表所适用的疾病类型不同，可分为普适性量表和疾病特异性量表[17]。目前，很多研究者在开展慢性肝炎患者生命质量评价时，考虑到慢性肝炎具有传染性，容易造成患者较重的心理负担，选择的量表除上述两大类，还包括心理健康测量量表[18]。本文旨在采用文献计量法分析中国发表的慢性肝炎患者生命质量评价的相关文献，以期为研究者开展慢性肝炎患者的生命质量评价，尤其是在健康相关生命质量量表选择方面提供参考借鉴。

1 资料与方法

2017年3—9月，计算机检索中国知网、万方数据知识服务平台、维普网和中国生物医学文献数据库，以“篇名/关键词/摘要”为检索项，“生命质量量表/生存质量量表/生活质量量表”或“生命质量/生存质量/生活质量”+“肝炎/慢性肝炎/乙肝/丙肝/肝硬化/肝病”等为检索词，检索时间截至2016年12月（不设起始时间），共获得相关文献362篇。由于肝癌病因复杂，不仅包括慢性肝炎最终进展导致的原发性肝细胞癌，还包括肠癌、胰腺癌等转移导致的继发性肝癌，而在许多文献中研究者并未明确表明开展生命质量评价的肝癌患者属于哪一类，因此评价肝癌患者生命质量的研究不纳入本文分析范围。根据题录，初步判断后剔除未应用量表、研究内容与慢性肝炎患者健康相关生命质量评价无关、量表研制、文献综述、国外论文翻译及重复发表等文献，最终确定有效文献233篇。建立Excel数据库，通过共词聚类法分析提取的文献基本情况、研究内容、测评量表等。

2 结果

2.1 基本情况分析

2.1.1 收录及数量分布 纳入的233篇文献中，包含221篇（94.85%）期刊文献及12篇（5.15%）会议文献，119篇（53.85%）期刊文献被收录于北京大学图书馆核心期刊目录或中国科技核心期刊目录的64种期刊发表，7篇会议文献则被全国消化系统或肝胆等疾病领域的专业会议论文集收录。第1篇文献发表于1999年《中国民政医学杂志》，此后文献数量总体呈逐年增长趋势，从2006年开始每年发表的文献数量超过10篇，其中2013年发表的文献量最多（30篇，见图1）。

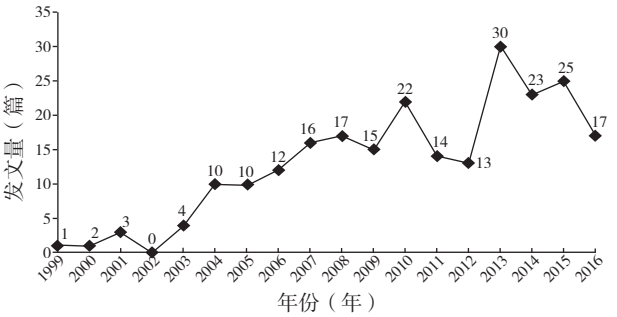

图1 慢性肝炎领域健康相关生命质量文献的年发文量

Figure 1 Annual published number of articles about health-related quality of life assessment in chronic hepatitis patients

2.1.2 研究对象的地区分布 研究对象分布于全国28个省（自治区、直辖市），其中针对广东、北京、江苏、山东等地区人群进行的研究较多，研究对象分布数量前10的地区占69.96%（163/233，见表1）。

2.1.3 著者信息及资助情况 纳入文献共包括作者770人，篇均作者为3.30人，其中独著文献有57篇（24.46%），作者人数为2~3人、3人以上的文献分别有83篇（35.62%）、93篇（39.92%）。202篇（86.70%）文献第一作者来自医疗机构，其次为高校（28篇，12.02%），3篇（1.28%）文献第一作者来自医药行业行政管理部门。

仅43篇（18.45%）文献标明了研究经费来源。其中，期刊文献获得国家级、省部级、市州级、校级等科研基金资助

www.chinagp.net ©C.G.P.

表 1 慢性肝炎领域健康相关生命质量文献研究对象的地区分布
Table 1 Regional distribution of the participants in the included articles

地区	文献数量（篇）	构成比（%）
广东	24	10.30
北京	20	8.58
江苏	19	8.15
山东	19	8.15
上海	16	6.87
河北	16	6.87
湖北	14	6.01
河南	13	5.58
浙江	11	4.72
陕西	11	4.72
其他	70	30.05
合计	233	100.00

的文献分别为 12 篇（5.15%）、21 篇（9.01%）、14 篇（6.01%）、1 篇（0.43%），仅有 2 篇（0.86%）会议文献标明获得国家级科研基金资助。

2.2 研究内容分析

2.2.1 疾病类型及样本来源 173 篇（74.25%）文献针对慢性乙型肝炎，其次为肝硬化（33 篇，14.16%），12 篇（5.15%）针对慢性丙型肝炎，7 篇（3.00%）针对其他慢性肝病（如酒精肝、脂肪肝），8 篇（3.44%）未明确说明疾病类型。在研究样本的来源方面，基于取样方便、有代表性等原则，210 篇（90.13%）文献的研究样本来自医疗机构的患者，14 篇（6.01%）文献来自社区患者，5 篇（2.15%）文献来自医疗机构照护患者的家属，4 篇（1.71%）文献未说明。

2.2.2 干预措施 103 篇（44.21%）文献是对患者在研究期间的生命质量现状进行的单次评价，130 篇（55.79%）则是对单一或多个干预措施对患者生命质量的影响进行评价。采取的干预措施主要有护理干预（59 篇，45.38%）、药物治疗（37 篇，28.46%）、健康教育（30 篇，23.08%）和手术治疗（4 篇，3.08%）。4 类干预措施中，采用较多的分别为综合性的临床护理（23 篇），干扰素治疗（15 篇），对患者知、信、行等方面的干预手段（21 篇），针对终末期肝硬化患者采取的肝移植术（2 篇）。

2.3 量表应用情况

2.3.1 不同类型量表总体应用情况 运用普适性量表、特异性量表和心理健康测量量表评价慢性肝炎患者生命质量的文献分别有 184 篇（78.97%）、61 篇（26.18%）、47 篇（20.17%），应用频次分别有 198、64、96 次。其中，应用的普适性量表有 18 种，主要有健康调查简表（SF-36）为 114 次（57.58%），世界卫生组织生存质量测定量表简表（WHOQOL-BREF）为 27 次（13.64%），生活质量综合评定问卷（GQOLI-74）为 17 次（8.58%）。应用的特异性量表有 22 种，主要有慢性肝病问卷（CLDQ）为 36 次（56.25%），疾病医学应对问卷（MCMQ）为 6 次（9.38%），中医类肝炎患者生命质量测定量表为 5 次（7.81%）。应用的心理健康测量量表有 10 种，主要有抑郁自评量表（SDS）为 34 次（35.42%），焦虑自评量表（SAS）为 32 次（33.33%），90 项症状自评量表（SCL-90）为 14 次（14.58%）。另外，应用研究者自制或通过文献追溯无法确定量表确切研发机构或研发者的普适性量表、特异性量表和心理健康测量量表分别有 11、12、4 次。排除通过文献追溯无法确定量表确切研发机构或研发者的文献，应用国外研究机构或研究者开发的普适性量表、特异性量表和心理健康测量量表分别有 150（75.76%）、42（65.63%）、92（95.83%）次，应用国内量表分别有 37（18.69%）、10（15.63%）、0 次（见表 2）。

表 2 慢性肝炎领域健康相关生命质量文献中各类量表应用频次
Table 2 Using times of health-related quality of life instruments in the included articles for chronic hepatitis patients

名称量表	研发机构 / 学者	应用频次〔n（%）〕
普适性量表		
健康调查简表（SF-36）	美国波士顿健康研究所[19]	114（57.58）
世界卫生组织生存质量测定量表简表（WHOQOL-BREF）	世界卫生组织[20]	27（13.64）
生活质量综合评定问卷（GQOLI-74）	李凌江等[21]	17（8.58）
社会支持评定量表（SSRS）	肖水源[22]	16（8.08）
世界卫生组织生存质量测定量表（WHOQOL-100）	世界卫生组织[23]	6（3.03）
生活质量指数评定量表	黄津芳等[24]	4（2.02）
生活质量测量问卷	ZHAN[25]	3（1.52）
其他	自制或无法确定	11（5.55）
合计		198（100.00）
特异性量表		
慢性肝病问卷（CLDQ）	YOUNOSSI 等[26]	36（56.25）
疾病医学应对问卷（MCMQ）	FEIFEL 等[27]	6（9.38）
中医类肝炎患者生命质量测定量表		
慢性肝病中医生存质量量表（TCHB-PRO）	王妍等[28]	3（4.69）
中医证候量表	林彦[29]	1（1.56）
中医肝病 PRO 量表（PRO）	陈非凡[30]	1（1.56）
慢性肝炎患者生命质量测定量表（QLICD-CH）	万崇华等[31]	3（4.69）
肝病特有症状问卷（SS）	王凤云等[32]	2（3.12）
其他	自制或无法确定	12（18.75）
合计		64（100.00）
心理健康测量量表		
抑郁自评量表（SDS）	ZUNG 等[33]	34（35.42）
焦虑自评量表（SAS）	ZUNG 等[33]	32（33.33）
90 项症状自评量表（SCL-90）	DEROGATIS 等[34]	14（14.58）
汉密顿抑郁量表（HAMD）	HAMILTON 等[35]	7（7.29）
一般自我效能感量表（GSES）	SEHWARZER 等[36]	3（3.13）
特质应对方式问卷（TCSQ）	FOLKMAN 等[37]	2（2.08）
其他	自制或无法确定	4（4.17）
合计		96（100.00）

注：ZUNG 等[33] 和 HAMILTON 等[35] 来源于二次文献

2.3.2 各类量表的应用情况 研究者单独选用普适性量表的文献最多（124 篇，53.22%），其次为混合应用两类及以上量表的文献（75 篇，32.18%），而单独选用特异性量表、心理健康测量量表的文献各有 17 篇（7.30%，见表 3）。

单独选用普适性量表的 124 篇文献中，应用 SF-36 有 83 篇（66.94%），应用 SF-36/WHOQOL-BREF+ 社会支持评定量表（SSRS）有 6 篇（4.84%）。单独应用特异性量表的 17 篇文献中，应用 CLDQ 有 8 篇，CLDQ+MCMQ/ 慢性肝病中医生存质量量表（TCHB-PRO）/ 中医证候量表 3 篇。单独应用心理健康测量量表的 17 篇文献中，应用 SCL-90 有 3 篇，应用 SAS+SDS 有 8 篇，应用 SCL-90+SAS+SDS 有 2 篇。

www.chinagp.net

表 3 评价不同疾病类型患者的文献量表应用情况〔n（%）〕
Table 3 Using times of chronic hepatitis-specific health-related quality of life instruments in the included articles by type of chronic hepatitis

疾病类型	篇数	仅应用普适性量表	仅应用特异性量表	仅应用心理健康测量量表	应用两类及以上量表
慢性乙型肝炎	173	89（51.45）	14（8.09）	12（6.94）	58（33.52）
肝硬化	33	22（66.67）	2（6.06）	2（6.06）	7（21.21）
慢性丙型肝炎	12	7（7/12）	1（1/12）	0	4（4/12）
其他慢性肝病	7	2（2/7）	0	1（1/7）	4（4/7）
未明确说明	8	4（4/8）	0	2（2/8）	2（2/8）
合计	233	124（53.22）	17（7.30）	17（7.30）	75（32.18）

在 26 篇应用普适性 + 特异性量表的文献中，以 SF-36/WHOQOL-BREF+CLDQ 最多（13 篇，50.00%）；在 35 篇应用普适性 + 心理健康测量量表的文献中，以 SF-36/WHOQOL-BREF/GQOLI-74+SAS/SDS 最多（16 篇，45.71%）；在 10 篇应用特异性 + 心理健康测量量表的文献中，以 CLDQ+SAS/SDS 最多（3 篇）；在 4 篇同时应用 3 类量表的文献中，应用 WHOQOL-BREF+CLDQ/ 社会功能缺陷筛选量表（SDSS）/ 服药依从性量表 +SAS/SDS 有 3 篇。

3 讨论

本研究结果显示，自 2004 年，健康相关生命质量量表在慢性肝炎领域中的应用研究总体数量呈逐年增长趋势。研究对象多分布在广东、北京、江苏等经济、医疗水平较为发达的地区，并且研究者多来源于医疗机构的医护人员，研究内容主要集中在对慢性乙型肝炎、慢性丙型肝炎、肝硬化等不同类型的肝炎患者生命质量现状进行单次评价，或是采取护理干预、药物治疗、健康教育、手术治疗等单一或多个干预措施后对生命质量产生的影响开展评价。

开展生命质量评价时，67.81%（158/233）的研究者仅选用普适性量表、特异性量表或心理健康测量量表中的一类，其中应用频次较高的量表分别为 SF-36、CLDQ、SAS+SDS。32.19%（75/233）的研究者选择了两类及以上组合应用，应用频次较高的组合分别为 SF-36/WHOQOL-BREF+CLDQ、SF-36/WHOQOL-BREF/GQOLI-74+SAS/SDS、CLDQ+SAS/SDS 等。上述量表均为国外研究机构或研究者开发，其优势在于运用广泛，信度和效度较高，但经过翻译后用于评价国人生命质量，其适用性仍然存在较大争议。部分学者如李跃平等[38]、崔伟红等[10]研究表明，SF-36 并不能测量出患者生命质量的全部改变，尤其是在个体对自身精力和疲劳程度的主观感受方面，用于评价慢性乙型肝炎患者生命质量时需要进一步修正。

另外，也有部分研究者选用了国内学者研制开发的量表，如李凌江等[21]研制的 GQOLI-74，肖水源[22]研制的 SSRS，黄津芳等[24]研制的生活质量指数评定量表等普适性量表；万崇华等[31]研制的包含共性模块（QLICD-GM）和各种慢性病特异性模块的慢性病患者生命质量测定量表体系（QLICD），以及根据中医肝病理论的指导，王妍等[28]、林彦[29]、陈非凡[30]研制的中医类肝炎患者生命质量测定量表等疾病特异性量表。这些量表主要是针对我国人群特征研发，但目前应用频次较少，由国内研究机构或研究者开发的普适性量表和特异性量表应用频次仅为 20% 左右，心理健康测量量表应用频次甚至为 0。目前，国内已有的量表在研制程序、样本选择、人群适应性探究方面仍需要进一步完善。

本研究仍然存在一定的局限性，检索的文献仅局限于国内数据库，对于国内作者发表于国外期刊的相关研究未进行检索分析。但本研究将国内作者用于评价慢性肝炎患者生命质量的各类量表进行了统计分析，在一定程度上，能为其他学者开展相关研究时提供参考。

综上所述，尽管我国慢性肝炎领域的健康相关生命质量评价在过去几十年得到了较快的发展，文献数量不断攀升，但仍然存在着几方面的问题：单独应用普适性量表开展评价的文献较多，组合应用不同类型量表的文献少；国外量表应用频次高，而国内自行开发的量表数量较少，应用频次也较低；评价慢性乙型肝炎患者生命质量的文献较多，评价其他类型疾病的文献较少等。因此，选择恰当的生命质量量表测评慢性肝炎患者的生命质量，从而指导临床治疗，尚需进一步探索。

作者贡献：冉雪蓉进行文章的构思与设计，整理数据并统计学分析，撰写论文；张堂钦、蔡一凡、罗奎负责文献检索、指标提取与整理；杨星、张满进行结果的分析与解释；伍红艳负责文章的质量控制和审校，对文章整体负责，监督管理。

本文无利益冲突。

参考文献

[1] 梅长林，李兆申，朱樑 . 内科手册［M］. 7 版 . 北京：人民卫生出版社，2011：155-156.
MEI C L，LI Z S，ZHU L.Internal medicine manual［M］. 7th ed.Beijing：People's Medical Publishing House，2011：155-156.

[2] 拉米夫定临床应用专家组，万谟彬 .2004 年拉米夫定临床应用专家共识［J］. 中华肝脏病杂志，2004，12（7）：425-428.
Lamivudine Clinical Application Expert Group，WAN M B.Expert consensus of lamivudine clinical application 2004［J］. Chinese Journal of Hepatology，2004，12（7）：425-428.

[3] WANG F S，FAN J G，ZHANG Z，et al. The global burden of liver disease：the major impact of China［J］. Hepatology，2014，60（6）：2099-2108. DOI：10.1002/hep.27406.

[4] 崔妹娟 . 丙型肝炎病毒感染危险因素的病例对照研究［D］. 北京：中国疾病预防控制中心，2014.
CUI M J.Risk factors for hepatitis C virus infection：a case-control study［D］. Beijing：Chinese Center for Disease Control and Prevention，2014.

[5] 江山 . 酒精性肝硬化和乙肝肝硬化患者血清代谢组学初步研究［D］. 杭州：浙江大学，2011.
JIANG S.Preliminary study on serum metabonomics in patients with alcoholic liver cirrhosis and hepatitis B cirrhosis［D］. Hangzhou：Zhejiang University，2011.

[6] 许嘉，巴蕾，吴文仓，等. 脂肪肝的流行病学研究进展［J］. 慢性病学杂志，2013，14（7）：539-542.
XU J，BA L，WU W C，et al. Epidemiological studies progress of fatty liver［J］. Chronic Pathemathol Journal，2013，14（7）：539-542.

[7] 李云云，许卫国，朱立国，等. 慢性乙肝患者生命质量及影响因素分析［J］. 中国公共卫生，2013，29（11）：1574-1576. DOI：10.11847/zgggws2013-29-11-05.

www.chinagp.net C.G.P.

LI Y Y，XU W G，ZHU L G，et al. Quality of life and its influencing factors among chronic hepatitis B patients［J］. Chinese Journal of Public Health，2013，29（11）：1574-1576. DOI：10.11847/zgggws2013-29-11-05.

［8］王超秀.慢性肝炎患者生命质量测定量表的研制与考评［D］. 昆明：昆明医学院，2011.

［9］中华医学会传染病与寄生虫病学分会，中华医学会肝病学分会.病毒性肝炎防治方案［J］. 中华内科杂志，2000，19（1）：56-62.
Branch of Infectious Diseases and Parasitology，Branch of Hepatology，Chinese Medical Association.Prevention and treatment programs of viral hepatitis［J］. Chinese Journal of Internal Medicine，2000，19（1）：56-62.

［10］崔伟红，范桂玲，胡茂红，等. SF-36量表用于慢性乙型肝炎生命质量测定的效果评价［J］. 医学与哲学，2007，28（9）：31-33.
CUI W H，FAN G L，HU M H，et al. The effect evaluation on measuring quality of life in chronic hepatitis B patients by SF-36 scale［J］. Medicine and Philosophy，2007，28（9）：31-33.

［11］疾病预防控制局. 2016年全国法定传染病疫情概况［EB/OL］.（2017-02-23）［2017-10-15］. http：//www.nhfpc.gov.cn/jkj/s3578/201702/38ca5990f8a54ddf9ca6308fec406157.shtml.

［12］李广峰.大黄的药理作用及临床应用分析［J］. 中国医药指南，2013，11（16）：317-318.
LI G F.Pharmacological effects and clinical application analysis of rhubarb［J］. Chinese Medicine Guide，2013，11（16）：317-318.

［13］傅英兰，窦乐功，尤龙.慢性乙型肝炎的抗病毒治疗进展［J］. 山东医药，2002，42（13）：60-61.
FU Y L，DOU L G，YOU L.Advances in antiviral therapy of chronic hepatitis B［J］. Shandong Medical Journal，2002，42（13）：60-61.

［14］谢莹.慢性肝病患者内在力量、自我效能与生命质量的相关性研究［D］. 延边：延边大学，2016.

［15］高国福，郭欣，张颖，等. 生存质量研究概述［J］. 实用预防医学，2000，25（6）：479-481.
GAO G F，GUO X，ZHANG Y，et al. Quality of life research overview［J］. Practical Preventive Medicine，2000，25（6）：479-481.

［16］伍红艳，田彩林.2009—2013年国内药物经济学评价类文献之质量分析［J］. 中国药房，2015，26（11）：1441-1445. DOI：10.6039/j.issn.1001-0408.2015.11.01.
WU H Y，TIAN C L.Quality analysis of pharmacoeconomics evaluation and application literature in China during 2009—2013［J］. China Pharmacy，2015，26（11）：1441-1445. DOI：10.6039/j.issn.1001-0408.2015.11.01.

［17］伍红艳.健康效用值测量研究［D］. 沈阳：沈阳药科大学，2012.

［18］张利霞，李星丹，郑蔚，等. 慢性肝病患者的生存质量量表应用现状［J］. 中国实用神经疾病杂志，2012，15（2）：8-10.
ZHANG L X，LI X D，ZHENG W，et al. Application status of quality of life scale in patients with chronic liver disease［J］. Chinese Journal of Practical Nervous Diseases，2012，15（2）：8-10.

［19］WARE J E，SNOW K K，KONINSKI M.SF-36 health survey：manual and interpretation guide［M］. Boston，MA：New England Medical Center，1993.

［20］WHOQOL Group.Development of the World Health Organization WHOQOL-BREE quality of life assessment［J］. Psycho Med，1998，28：551-558.

［21］李凌江，郝伟，杨德森，等. 社区人群生活质量研究—Ⅲ生活质量问卷（QOLI）的编制［J］. 中国心理卫生杂志，1995，9（5）：227-231.
LI L J，HAO W，YANG D S，et al. Quality of life of community population— establishment of Quality of Life Questionnaire（QOLI）［J］. Chinese Mental Health Journal，1995，9（5）：227-231.

［22］肖水源.《社会支持评定量表》的理论基础与研究应用［J］. 临床精神医学杂志，1994，4（2）：98-100.
XIAO S Y.The theoretical foundation and research application of Social Support Rating Scale［J］. Journal of Clinical Psychiatry，1994，4（2）：98-100.

［23］WHOQOL Group.The World Health Organization Quality of Life assessment（WHOQOL）：development and general psychometric properties［J］. Soc Sci Med，1998，46（12）：1569-1585.

［24］黄津芳，刘玉莹.护理健康教育学［M］. 北京：科学技术出版社，2002：60.

［25］ZHAN L.Quality of life：conceptual and measurement issues［J］. J Adv Nurse，1992，17（7）：795-800.

［26］YOUNOSSI Z M，GUYATT G，KIWI M，et al. Development of a disease specific questionnaire to measure health related quality of life in patients with chronic liver disease［J］. Gut，1999，45（2）：295-300.

［27］FEIFEL H，STRACK S，NAGY V T.Coping strategies and associated features of medically ill patients［J］. Psychosom Med，1987，49（6）：616-625.

［28］王妍，王俐琼，张玮，等. 中医QOL量表（测试版）对于慢性乙型肝炎湿热中阻证患者应用评价研究［J］. 中西医结合肝病杂志，2016，26（1）：23-25. DOI：103969/j.issn.1005-0264.2016.01.009.
WANG Y，WANG L Q，ZHANG W，et al. The application of QOL Scale（test version）to the patients with chronic hepatitis B dampness and heat resistance［J］. Chinese Journal of Integrated Traditional and Western Medicine on Liver Diseases，2016，26（1）：23-25. DOI：103969/j.issn.1005-0264.2016.01.009.

［29］林彦.肝炎后肝硬化患者生存质量与中医证候的相关性研究［D］. 上海：上海中医药大学，2008.
LIN Y.Study on the correlation between survival quality and TCM syndrome in patients with post-hepatitis cirrhosis［D］. Shanghai：Shanghai University of Traditional Chinese Medicine，2008.

［30］陈非凡.中医肝病PRO量表的研制与考核［D］. 广州：广州中医药大学，2007.
CHEN F F.Development and assessment of PRO Scale of liver disease in TCM［D］. Guangzhou：Guangzhou University of Chinese Medicine，2007.

［31］万崇华，李晓梅，杨铮，等. 慢性病患者生命质量测定与应

www.chinagp.net CGP

用［M］. 北京：科学出版社，2015：62-65，186-199.
WAN C H，LI X M，YANG Z，et al. Determination and application of life quality in patients with chronic diseases［M］. Beijing：Science Press，2015：62-65，186-199.
［32］王凤云，唐旭东，张引强，等. 影响慢性乙型肝炎患者生存质量因素调查与分析［J］. 胃肠病学和肝病学杂志，2010，19（5）：404-407.
WANG F Y，TANG X D，ZHANG Y Q，et al. Investigation and analysis of factors for the quality of life in patients with chronic hepatitis B［J］. Chinese Journal of Gastroenterology and Hepatology，2010，19（5）：404-407.
［33］汪向东. 心理卫生评定量表手册［M］. 北京：中国心理卫生杂志社，1993：160-161.
WANG X D.Mental health rating scale manual［M］. Beijing：Chinese Mental Health Journal，1993：160-161.
［34］DEROGATIS L R，RICKELS K，ROCK A F.The SCL-90 and the MMPI：a step in the validation of a new self-report scale［J］. Br J Psychiatry，1976，128（3）：280-289.
［35］张明园. 精神科评定量表手册［M］. 长沙：湖南科技出版社，1993：122-127.
ZHANG M Y.Psychiatric rating scale manual［M］. Changsha：Hunan Science and Technology Press，1993：122-127.
［36］SEHWARZER R，ARISTI B.Optimistic self beliefs：assessment of general perceived self efficacy in thirteen cultures［J］. Word Psychology，1997，3（1/2）：177-190.
［37］FOLKMAN S，LAZARUS R S，GRUEN R J.Appraisal，coping，health status，and psychological symptoms［J］. J Pers Soc Psychol，1986，50（3）：571-579.
［38］李跃平，黄子杰，张宏，等. SF-36 量表在乙型肝炎患者生存质量测量中的可行性评价［J］. 中国预防医学杂志，2007，8（4）：352-355.
LI Y P，HUANG Z J，ZHANG H，et al. Feasibility of the MOS 36-item short health survey in the assessment of life in hepatitis B patients［J］. Chinese Prevention Medicine，2007，8（4）：352-355.

（收稿日期：2018-01-18；修回日期：2018-05-31）
（本文编辑：吴立波）

·全科医生工具箱·

请您收藏
——2018 国际儿童青少年糖尿病协会（ISPAD）临床实践指南：青少年儿童糖尿病确诊时的教育主题

国际儿童青少年糖尿病协会（ISPAD）发布了 2018 年版青少年儿童糖尿病教育指南，该指南在 2014 年版的基础上，对青少年儿童糖尿病教育的相关内容进行了更新，对患儿在被确诊为糖尿病时的教育主题做出了以下推荐。

1. 向患儿（及其照护者）简单解释诊断过程、引起症状的原因和终身胰岛素治疗的必要性，并肯定胰岛素治疗可以快速恢复健康活力状态。
2. 探究因为患糖尿病，患儿及其照护者的懊悔或者责任归咎情况，并与其探讨引起糖尿病的不确定因素。
3. 对患儿（及其照护者）得知诊断后的悲伤和反应失控等情况进行管理。
4. 讨论患儿兄弟姐妹的患病风险，并为使此风险降低到最低限度，给出干预建议。
5. 向患儿（及其照护者）简单讲解血糖，以及食物、血糖和胰岛素之间的关系。
6. 向患儿（及其照护者）简单讲解胰岛素治疗可降低血糖，速效胰岛素可快速降低血糖，而长效胰岛素则可以缓慢降低血糖。
7. 与患儿（及其照护者）一起讨论家庭成员在辅导和监督患儿进行自我管理中的作用和责任，及其所期望地对患儿的随访频率。
8. 与患儿（及其照护者）一起制定清晰的整体治疗目标和具体治疗目标，并使两类目标总体保持一致。
9. 对患儿（及其照护者）强调，从治疗开始就要重视基本的糖尿病自我管理技巧。学会这些技巧能提高其进行糖尿病管理的信心。对患儿（及其照护者）在 8 个方面〔血糖监测和 / 或动态血糖监测、血酮监测、胰岛素注射装置（笔或泵）的使用、胰岛素注射部位的了解 / 注射技术、糖尿病自我管理日记书写情况（书写内容和书写频率）；胰岛素计算器的使用；糖尿病碳水化合物计数器的使用；胰岛素的储存〕的能力进行评估。
10. 向患儿（及其照护者）就基本饮食（包括食物中碳水化合物含量和健康饮食的重要性和日常饮食时间），以及如何更好地进行体质量管理给出建议，并讲解食物与糖尿病的关系，以及树立患儿（及其照护者）“蜜月期”能治愈的信念。
11. 向患儿（及其照护者）讲解低血糖的症状、预防和管理，糖尿病身份卡、项链、手镯和其他设备的使用，高血糖和糖尿病酮症酸中毒的症状、预防和管理。
12. 建议同时患有其他疾病的患儿继续应用胰岛素，可向糖尿病管理团队打电话咨询相关事宜。
13. 建议患儿将糖尿病自我管理融入家庭生活、社会活动、体育活动和学校生活中。
14. 解答患儿或其照护者提出的糖尿病对将来就业、生育等方面的影响的问题。
15. 向患儿（及其照护者）介绍糖尿病协会会员服务和其他可获得的支持服务。
16. 登记患儿（及其照护者）紧急联系电话和记录随访安排事项。

（详细内容见：https：//cdn.ymaws.com/www.ispad.org/resource/resmgr/consensus_guidelines_2018_/6.diabetes_education_in_chil.pdf）

（本刊编辑部整理）

C.G.P. www.chinagp.net